



Doenças Funcionais do Trato Gastrointestinal

APOSTILA — PARTE 2

Esta segunda parte da apostila aborda com profundidade dois dos distúrbios funcionais mais prevalentes na prática clínica gastroenterológica: a **constipação funcional** e a **diarreia funcional**. Compreender seus mecanismos fisiopatológicos, critérios diagnósticos e abordagens terapêuticas é essencial para o especialista que deseja oferecer cuidado de excelência ao paciente com queixas do trato gastrointestinal inferior.

Constipação — Introdução Clínica

Por que é relevante?

A constipação é uma das queixas mais prevalentes em gastroenterologia, afetando entre **15% e 20%** da população geral, com maior incidência em mulheres, idosos e populações de baixa renda. Seu impacto é significativo: reduz a qualidade de vida, gera absenteísmo e representa alto consumo de recursos médicos, incluindo consultas, exames e hospitalização.

Armadilha diagnóstica

A definição clínica de constipação deve ir **além da simples frequência evacuatória**. Muitos pacientes evacúam diariamente e ainda assim relatam constipação — seja por fezes endurecidas, esforço excessivo ou sensação de esvaziamento incompleto. Ignorar essa dimensão subjetiva leva a subdiagnóstico e tratamento inadequado.

A anamnese detalhada e o uso de escalas validadas, como a **Escala de Bristol**, são ferramentas indispensáveis para uma avaliação precisa e reprodutível.

Definição Operacional de Constipação

Do ponto de vista clínico e segundo os **Critérios de Roma IV**, constipação é definida pela presença de dois ou mais dos seguintes critérios, presentes nos últimos 3 meses, com início há pelo menos 6 meses:

Frequência reduzida

Menos de **3 evacuações por semana**. Embora seja o critério mais conhecido, não deve ser o único avaliado, pois isoladamente tem baixa sensibilidade diagnóstica.

Esforço evacuatório

Necessidade de realizar **força excessiva** durante pelo menos 25% das evacuações. Reflete dificuldade de progressão do bolo fecal ou obstrução funcional à saída.

Sensação de evacuação incompleta

Percepção subjetiva de que o reto não foi completamente esvaziado após a evacuação, presente em pelo menos **25% das defecações**.

Fezes endurecidas

Consistência correspondente aos **tipos 1 ou 2 da Escala de Bristol** (cíbalos ou fezes em bloco) em pelo menos 25% das evacuações.

A Percepção do Paciente é Determinante

Um dos erros mais frequentes na abordagem da constipação é **tratar exclusivamente a frequência evacuatória**, negligenciando a experiência subjetiva do paciente. O conceito de constipação varia amplamente entre indivíduos: alguns consideram normal evacuar a cada 3 dias, enquanto outros sentem-se constipados mesmo evacuando diariamente, mas com dificuldade ou sensação de esvaziamento incompleto.

Erro clínico comum

- Focar apenas na frequência, ignorando consistência e esforço
- Não questionar sobre manobras digitais ou postura evacuatória
- Desconsiderar o impacto na qualidade de vida relatado pelo paciente
- Assumir que evacuação diária exclui constipação

Abordagem correta

- Ouvir ativamente a queixa sem presumir o diagnóstico
- Utilizar a Escala de Bristol para objetivar a consistência
- Quantificar esforço, completude e necessidade de manobras
- Avaliar impacto funcional e emocional do sintoma

Avaliação Clínica Inicial Sistematizada

A avaliação inicial da constipação deve ser estruturada para cobrir os principais domínios sintomáticos. Uma anamnese incompleta frequentemente leva a abordagens inespecíficas e ineficazes. Os quatro pilares da avaliação inicial são:

1

Frequência evacuatória

Quantas vezes por semana o paciente evacua? Houve mudança recente do padrão habitual? É fundamental comparar com o padrão basal individual.

2

Consistência (Escala de Bristol)

Classificar as fezes nos tipos 1 a 7. Tipos 1–2 indicam trânsito lento; tipos 6–7 sugerem trânsito acelerado. Ferramenta de fácil aplicação e reprodutível.

3

Esforço evacuatório

Quantificar a intensidade e frequência do esforço. Esforço em mais de 25% das evacuações é critério diagnóstico e pode sugerir distúrbio da defecação.

4

Manobras digitais

Perguntar diretamente sobre uso de manobras perineais, digitação retal ou vaginal para auxiliar a evacuação — sinal importante de distúrbio funcional do assoalho pélvico.

Sintomas Associados à Constipação

A constipação raramente se apresenta de forma isolada. Sintomas associados são frequentes e refletem a natureza sistêmica do distúrbio funcional intestinal, envolvendo o **eixo cérebro-intestino** e o sistema autonômico. Reconhecê-los é fundamental tanto para o diagnóstico diferencial quanto para a escolha terapêutica.

Distensão abdominal

Sensação de inchaço ou aumento do volume abdominal, frequentemente mais intensa no período vespertino. Pode ser objetiva (meteorismo) ou subjetiva.

Dor abdominal

Geralmente em cólica ou pressão, aliviada pela evacuação. Quando predominante, deve levantar suspeita de SII com constipação (SII-C).

Sensação de obstrução

Percepção de bloqueio anal ou retal durante a defecação. Sintoma cardinal dos distúrbios da defecação, como anismo e dissinergia.

Disfunções urinárias

Urgência, incontinência ou retenção urinária podem coexistir por compartilhamento do assoalho pélvico. Cefaleia e fadiga também são relatadas.

Sinais de Alarme — Quando Investigar

A presença de sinais de alarme muda completamente a abordagem: o foco deixa de ser funcional e passa a ser investigação obrigatória de causa orgânica, incluindo neoplasias colorretais, doenças inflamatórias e outras condições estruturais graves.



Perda de peso involuntária

Perda > 5–10% do peso corporal sem causa aparente, especialmente em curto período, exige investigação imediata.



Anemia e sangramento

Anemia ferropriva inexplicada ou hematoquezia/melena são indicações mandatórias de colonoscopia. Não assumir constipação funcional sem excluir neoplasia.



História familiar de câncer

Parentes de primeiro grau com câncer colorretal ou pólipos avançados antecipam a necessidade de rastreamento colonoscópico.



Idade > 50 anos e início recente

Mudança do hábito intestinal de início recente em paciente acima de 50 anos sem investigação prévia deve sempre ser investigada endoscopicamente.

Classificação Geral da Constipação

Antes de iniciar qualquer tratamento, o médico deve classificar corretamente o tipo de constipação. Essa etapa direciona toda a investigação e define a estratégia terapêutica mais adequada. Existem três grandes categorias:

1

Constipação Funcional - sem causa estrutural, relacionada a trânsito e defecação;

2

Constipação Secundária - causas endócrinas, neurológicas, metabólicas e medicamentosas identificáveis;

3

SII com Constipação (SII-C) - dor abdominal predominante associada à alteração do hábito intestinal

A diferenciação entre essas categorias depende de uma anamnese cuidadosa, do exame físico e, em casos selecionados, de exames complementares. A constipação funcional e a SII-C compartilham fisiopatologia, mas diferem na **predominância de dor** — critério que define a SII segundo Roma IV.

Constipação Secundária — Causas Sistêmicas

A constipação secundária resulta de uma condição médica identificável que compromete a motilidade intestinal por mecanismos diretos ou indiretos. É fundamental excluí-la antes de fechar o diagnóstico de constipação funcional. As principais categorias etiológicas são:

Causas Endócrinas e Metabólicas

Hipotireoidismo é a causa endócrina mais comum — reduz a motilidade por diminuição dos hormônios tireoidianos sobre o músculo liso. **Diabete mellito** causa neuropatia autonômica com dismotilidade intestinal. Hipercalcemia e hipocalcemia também comprometem a contratilidade colônica.

Causas Neurológicas

Doença de Parkinson, esclerose múltipla, lesões medulares e neuropatia diabética afetam diretamente o sistema nervoso entérico e autonômico. A constipação pode preceder em anos os sintomas motores do Parkinson.

Causas Estruturais e Outras

Estenose colônica, carcinoma obstrutivo, síndrome de Ogilvie e doença de Hirschsprung no adulto são causas estruturais que exigem investigação endoscópica ou radiológica. Gravidez e imobilidade prolongada também contribuem.

Medicamentos Associados à Constipação

A constipação induzida por medicamentos é subestimada na prática clínica. A revisão minuciosa da lista farmacológica do paciente deve ser parte obrigatória de toda avaliação. Os principais grupos implicados são:

Opióides

Causa mais frequente e relevante. Atuam em receptores μ no trato gastrointestinal, reduzindo o peristaltismo e aumentando o tônus esfíncteriano. Virtualmente todos os pacientes em uso crônico desenvolverão constipação.

Anticolinérgicos

Incluem antiespasmódicos, antipsicóticos, antihistamínicos e medicamentos para bexiga hiperativa. Bloqueiam a estimulação colinérgica da musculatura intestinal, reduzindo a motilidade.

Antidepressivos

Tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina) têm forte efeito anticolinérgico. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) raramente causam constipação, mas podem fazê-lo em doses elevadas.

Anti-hipertensivos e outros

Bloqueadores de canais de cálcio (verapamil, diltiazem), diuréticos (por hipocalcemia), ferro oral, antiácidos com alumínio e suplementos de cálcio são implicados frequentemente.

Constipação Funcional — Fisiopatologia

A constipação funcional é definida pela ausência de causa estrutural, inflamatória, metabólica ou medicamentosa identificável que justifique os sintomas. Trata-se de um distúrbio da função intestinal mediado por múltiplos fatores que se inter-relacionam:

Fatores envolvidos

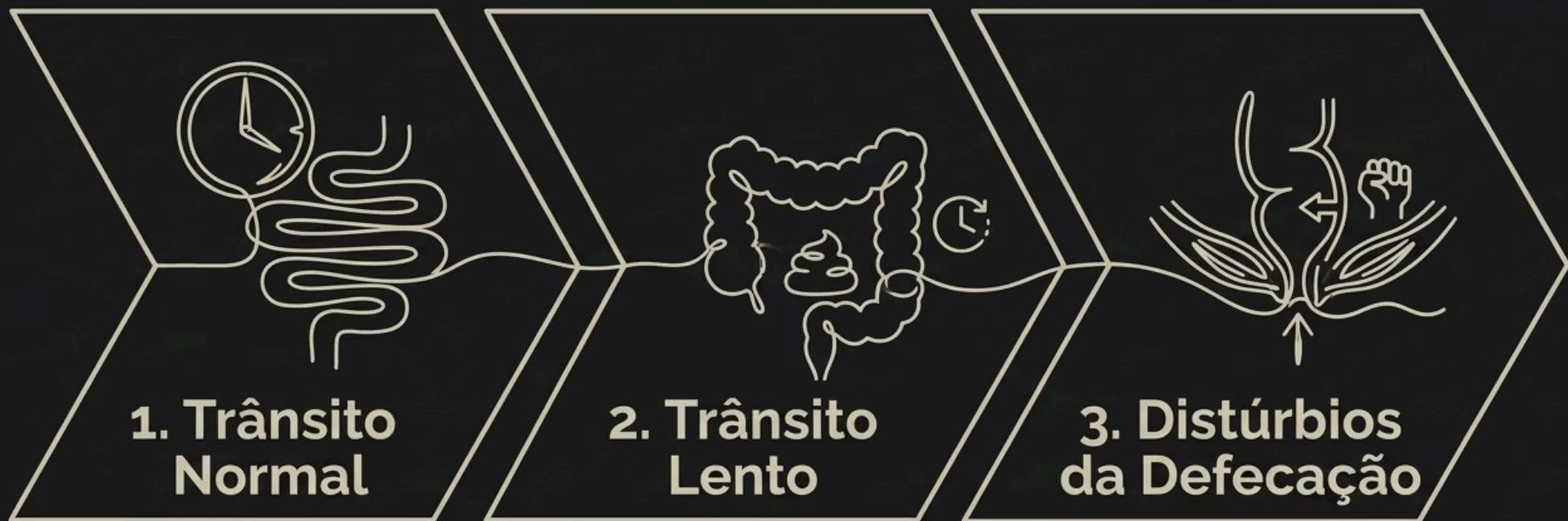
- **Dieta pobre em fibras:** reduz o volume e a consistência do bolo fecal, diminuindo o estímulo mecânico ao peristaltismo colônico
- **Baixa ingestão hídrica:** aumenta a reabsorção de água no cólon, endurecendo as fezes
- **Sedentarismo:** reduz o tônus da musculatura abdominal e diminui o trânsito intestinal por mecanismos neuroendócrinos
- **Componente psicológico:** ansiedade, depressão e estresse crônico modulam o eixo cérebro-intestino, alterando a motilidade e a sensibilidade visceral

Mecanismo central

A interação entre o **sistema nervoso central**, o **sistema nervoso entérico** e o **eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal)** é determinante na modulação da motilidade colônica. Alterações nesse eixo explicam por que pacientes com constipação funcional frequentemente apresentam comorbidades psiquiátricas e por que terapias comportamentais têm eficácia documentada.

Subtipos de Constipação Funcional

A classificação em subtipos é fundamental porque orienta diretamente a investigação e o tratamento. Cada subtipo tem mecanismo fisiopatológico distinto e responde de forma diferente às intervenções terapêuticas disponíveis.



- ❑ Na prática clínica, os subtipos podem coexistir no mesmo paciente. A avaliação fisiológica com manometria anorretal e teste de expulsão do balão é necessária para diferenciar trânsito lento de distúrbio da defecação antes de escalonar o tratamento.

Trânsito Normal — O Subtipo Mais Prevalente

Perfil clínico

No subtipo de trânsito normal, os exames de trânsito colônico (cintilografia ou marcadores radiopacos) são **completamente normais**. O paciente evacua com frequência adequada, mas percebe a defecação como insatisfatória, difícil ou incompleta. É o subtipo mais prevalente e está fortemente associado a fatores psicossociais e hipersensibilidade visceral.

Características e manejo

- Exames de trânsito colônico: normais
- Manometria anorretal: geralmente normal
- Componente de hipersensibilidade visceral frequente
- Alta sobreposição com síndrome do intestino irritável
- Resposta favorável a intervenções comportamentais e neuromoduladoras
- Educação do paciente e desmistificação são pilares do tratamento

O diagnóstico correto evita **investigações desnecessárias** e o uso inapropriado de laxantes.

Trânsito Lento — Características e Fisiopatologia

O trânsito colônico lento é caracterizado pelo **retardo documentado** da progressão do conteúdo fecal pelo cólon, resultando em fezes ressecadas, compactadas e evacuações muito infrequentes. A fisiopatologia envolve alterações estruturais e funcionais do sistema neuromuscular entérico:

Redução das células de Cajal

As células intersticiais de Cajal (ICC) são os "marca-passos" do peristaltismo intestinal. Estudos histológicos mostram redução significativa dessas células em pacientes com trânsito lento grave, comprometendo a geração e propagação das ondas contráteis de alta amplitude (HAPC).

Disfunção neuromuscular entérica

Alterações nos neurônios inibitórios e excitatórios do plexo mioentérico levam a desequilíbrio entre contração e relaxamento. Há redução dos neurotransmissores excitatórios (como a serotonina) e aumento relativo de mediadores inibitórios, resultando em hipomotilidade colônica.

Características Clínicas do Trânsito Lento

Padrão evacuatório

Evacuações extremamente raras, podendo ocorrer **menos de 1 vez por semana**. As fezes são do tipo 1 da Escala de Bristol (cibalos duros e secos). A sensação de urgência evacuatória é praticamente ausente.

Resposta a laxantes

Caracteristicamente, esses pacientes apresentam **baixa resposta a laxantes osmóticos e estimulantes** convencionais, o que diferencia clinicamente do trânsito normal. A ausência de resposta ao tratamento inicial deve motivar investigação do trânsito.

Sintomas sistêmicos

Além da constipação, podem ocorrer **náuseas, anorexia, distensão abdominal importante, fadiga e mal-estar geral**. Esses sintomas refletem o comprometimento mais global da motilidade gastrointestinal em casos graves.

Perfil epidemiológico típico

O trânsito lento acomete predominantemente **mulheres jovens**, frequentemente com início dos sintomas na adolescência ou início da vida adulta. A associação com histórico de abuso, ansiedade crônica e outros distúrbios funcionais é bem documentada na literatura.

Inércia colônica — forma grave

A **inércia colônica** representa o extremo do trânsito lento: ausência do reflexo gastrocólico, falta de ondas propulsivas de alta amplitude e resistência a praticamente todos os tratamentos farmacológicos. Nesses casos selecionados, a colectomia subtotal pode ser considerada.

SUBTIPO COMPLEXO

Distúrbios da Defecação

Os distúrbios da defecação, também chamados de **disfunção do assoalho pélvico** ou **obstrução funcional de saída**, representam um grupo heterogêneo de condições caracterizadas pela incapacidade de coordenar adequadamente a musculatura pélvica durante a defecação. São frequentemente subdiagnosticados e resistentes ao tratamento com laxantes convencionais.



Anismo (contração paradoxal)

Contração paradoxal ou falha no relaxamento do músculo puborretal e esfíncter externo durante o esforço evacuatório. Em vez de relaxar para permitir a passagem das fezes, o músculo **contraí**, criando obstrução funcional.



Dissinergia anorretal

Falta de coordenação entre a contração da musculatura abdominal (que gera pressão propulsiva) e o relaxamento esfíncteriano. Documentada pela manometria anorretal como falha na inibição reflexa do esfíncter.



Retocele e prolapso

A retocele é a herniação da parede anterior do reto para a vagina, criando um "bolsão" que retém fezes. O prolapso retal interno (intussuscepção) também obstrui a saída durante o esforço evacuatório.

Clínica dos Distúrbios da Defecação

Os pacientes com distúrbios da defecação apresentam um quadro clínico bastante característico, com predomínio de sintomas que refletem a **dificuldade mecânica ou funcional de saída**. Reconhecer esse padrão é fundamental para indicar os testes diagnósticos corretos e evitar tratamentos inadequados.

1

Esforço evacuatório intenso e prolongado

Os pacientes referem necessidade de realizar grande esforço por tempo prolongado, frequentemente passando mais de 15 a 20 minutos no banheiro sem conseguir evacuar adequadamente. O esforço é desproporcional ao volume fecal.

2

Sensação de evacuação incompleta

Mesmo após defecar, persiste a sensação de que há fezes retidas no reto. Esse sintoma pode levar a tentativas repetidas de defecação e esforço adicional, que piora o quadro.

3

Necessidade de manobras auxiliares

Muitos pacientes utilizam **manobras digitais** (digitação vaginal ou perineal) para auxiliar a evacuação. A presença dessas manobras é sinal patognomônico de distúrbio do assoalho pélvico e deve ser ativamente questionada na anamnese.

Critérios de Roma IV para Constipação Funcional

Os **Critérios de Roma IV** (2016) representam o padrão diagnóstico internacional para os distúrbios funcionais gastrointestinais. Para a constipação funcional, o diagnóstico exige a presença de **2 ou mais** dos seguintes critérios, nas últimas 12 semanas, com início há pelo menos 6 meses:

Critério A Esforço evacuatório em $\geq 25\%$ das defecações	Critério B Fezes endurecidas (tipos 1–2 Bristol) em $\geq 25\%$ das defecações
Critério C Sensação de evacuação incompleta em $\geq 25\%$ das defecações	Critério D Sensação de obstrução/bloqueio anorretal em $\geq 25\%$ das defecações
Critério E Manobras manuais para facilitar a evacuação em $\geq 25\%$ das defecações	Critério F Menos de 3 evacuações espontâneas completas por semana

❏ Importante: fezes líquidas raramente ocorrem sem uso de laxantes, e os critérios para SII não estão preenchidos (ausência de dor abdominal como sintoma predominante).

Constipação Funcional vs. SII com Constipação

A diferenciação entre constipação funcional (CF) e síndrome do intestino irritável com constipação (SII-C) é clinicamente relevante, pois impacta o tratamento e o prognóstico. O critério central de distinção é a **presença e predominância de dor abdominal**.

SII com Constipação (SII-C)

- **Dor abdominal recorrente** como sintoma central, presente em pelo menos 1 dia/semana no último trimestre
- A dor é relacionada à defecação (piora ou melhora após evacuar)
- Associada a alteração de frequência ou consistência das fezes
- Maior componente de sensibilização central e visceral
- Tratamento: neuromoduladores e antiespasmódicos têm papel central

Constipação Funcional (CF)

- Foco principal na **alteração do hábito evacuatório** — frequência, consistência, esforço
- Dor abdominal pode ocorrer, mas não é o sintoma predominante
- Sem relação obrigatória entre dor e defecação
- Mecanismo predominante: trânsito colônico lento ou distúrbio da defecação
- Tratamento: fibras, hidratação, laxantes e biofeedback têm papel central

Exame Físico na Constipação

O exame físico completo é parte indispensável da avaliação do paciente constipado. O **toque retal** merece destaque especial: é um procedimento simples, de baixo custo e altamente informativo, capaz de fornecer dados que nenhum exame complementar substitui de forma completa.

O que avaliar no toque retal

- **Tônus esfinteriano em repouso:** hipertonia sugere anismo; hipotonia sugere lesão neurológica
- **Resposta ao esforço (simulação de defecação):** o assoalho pélvico deve descer e o esfíncter deve relaxar
- **Contração paradoxal:** aumento do tônus ao esforço indica anismo/dissinergia
- **Fezes no ampola retal:** presença de fezes no reto em repouso sugere distúrbio da defecação; ausência sugere trânsito lento
- **Lesões estruturais:** massa, estenose, fissura anal, hemorroidas trombosadas

Inspeção perianal

- Cicatrizes de cirurgias prévias, fístulas, fissuras
- Descida perineal excessiva ao esforço
- Prolapso retal externo evidente
- Dermatite perianal (pode indicar vazamento fecal por paradoxo esfinteriano)

Testes Diagnósticos Fisiológicos

Quando a avaliação clínica inicial não é suficiente para classificar o subtipo de constipação, ou quando o paciente não responde ao tratamento empírico inicial, os testes fisiológicos anorretais são indicados. Eles fornecem informações objetivas sobre o funcionamento neuromuscular do reto e do assoalho pélvico.



Teste Expulsão Balão

Manometria
Anorretal

Defecografia

A sequência diagnóstica geralmente começa pelo **teste de expulsão do balão** (simples e acessível), seguido da **manometria anorretal** quando indicado, e pela **defecografia** para avaliação anatômica dinâmica em casos selecionados. Cintilografia de trânsito colônico ou cápsulas de marcadores radiopacos são utilizadas para documentar trânsito lento quando clinicamente suspeito.

Teste de Expulsão do Balão

Como é realizado

Um balão de látex é introduzido no reto e inflado com **50 mL de água**. O paciente é posicionado em banheiro ou comadre e solicitado a expelir o balão da forma mais natural possível. O tempo máximo aceitável é de **1 a 2 minutos** segundo os critérios mais utilizados.

Interpretação

- **Normal:** expulsão em menos de 1–2 minutos sem esforço excessivo
- **Anormal:** incapacidade de expelir ou necessidade de tempo prolongado — fortemente sugestivo de distúrbio da defecação

Vantagens

- Simples, de baixo custo e não invasivo
- Alta sensibilidade para dissinergia e anismo
- Pode ser realizado em ambulatório sem equipamento sofisticado
- Excelente triagem antes de manometria

Limitações

- Não quantifica pressões nem identifica o mecanismo específico
- Resultado pode ser influenciado por inibição do paciente
- Resultado negativo não exclui distúrbio leve da defecação

Manometria Anorretal — Padrão-Ouro

A manometria anorretal é considerada o **padrão-ouro** para avaliação funcional do assoalho pélvico e do mecanismo esfincteriano. Fornece dados quantitativos sobre pressão, sensibilidade e coordenação muscular que não podem ser obtidos por outros métodos.

O que avalia

- Pressão de repouso do canal anal (tônus interno)
- Pressão de contração voluntária máxima (esfincter externo)
- Reflexo inibitório retoanal (RIRA) — ausente na doença de Hirschsprung
- Sensibilidade retal (limiar de percepção, urgência, dor)
- Coordenação durante simulação de defecação

Achados diagnósticos

- **Dissinergia:** aumento paradoxal da pressão anal ao esforço defecatório
- **Hipossensibilidade retal:** limiar elevado para urgência — associado a trânsito lento
- **Hipersensibilidade retal:** urgência a pequenos volumes — associado a SII-C
- **Ausência de RIRA:** patognomônico de Hirschsprung do adulto



Defecografia — Avaliação Dinâmica

Indicações principais

A defecografia (convencional com bário ou por ressonância magnética — **defecoRM**) é indicada quando se suspeita de causa anatômica para os distúrbios da defecação, especialmente:

- Suspeita de retoccele anterior ou posterior
- Prolapso retal interno (intussuscepção)
- Enteroccele ou sigmoidoccele
- Descida perineal excessiva
- Investigação pré-operatória

O que o exame avalia

Permite avaliação **simultânea de anatomia e função** durante todo o ciclo defecatório (repouso, contração, esforço e evacuação). A defecoRM tem a vantagem de não usar radiação ionizante e permitir avaliação de múltiplos compartimentos pélvicos simultaneamente. É o método preferencial em mulheres com disfunção de múltiplos compartimentos (anterior, médio e posterior).



TRATAMENTO

Princípios do Tratamento da Constipação Funcional

O tratamento da constipação funcional deve ser **individualizado, progressivo e baseado no subtipo fisiopatológico** identificado. Uma abordagem escalonada, começando pelas medidas comportamentais e farmacológicas de primeira linha, é recomendada antes de considerar tratamentos mais complexos.

Laxantes osmóticos

Primeira linha para amolecer as fezes.

Procinéticos e secretagogos

Melhoram motilidade e secreção intestinal.

Medidas de estilo

Fibras, hidratação e rotina diária.

Biofeedback e terapias

Reabilitação e tratamentos especializados.

- ❑ Antes de iniciar tratamento farmacológico, é obrigatório excluir e corrigir causas secundárias (medicamentos, hipotireoidismo, diabetes etc.) e revisar a classificação do subtipo de constipação, pois o tratamento difere significativamente entre trânsito normal, trânsito lento e distúrbio da defecação.

Medidas Iniciais — Primeira Linha



Dieta rica em fibras

A ingestão recomendada é de **20 a 30 g de fibras por dia**. As fibras solúveis (psyllium, inulina) formam gel no cólon, aumentando o volume e a maciez das fezes. As insolúveis (farelo de trigo) acrescentam volume mecânico. O aumento deve ser gradual para evitar gases e distensão.



Rotina evacuatória

Orientar o paciente a **tentar evacuar no mesmo horário todos os dias**, preferencialmente 20–30 minutos após as refeições (aproveitando o reflexo gastrocólico). Posição de cócoras com apoio para os pés (degrau) otimiza o ângulo anorretal.



Hidratação adequada

Ingestão de pelo menos **1,5 a 2 litros de água por dia**. A hidratação é especialmente importante em pacientes em uso de fibras, pois sem água adequada as fibras podem piorar a constipação. Água morna em jejum pode estimular o reflexo gastrocólico.



Atividade física

Exercício físico regular (caminhada, musculação) melhora o trânsito intestinal por mecanismos neurais e mecânicos. Pacientes sedentários devem ser estimulados a incluir pelo menos **150 minutos/semana** de atividade moderada.

Laxantes Osmóticos — Primeira Linha Farmacológica

Os laxantes osmóticos são a principal opção farmacológica de primeira linha para constipação funcional, com boa eficácia, segurança e tolerabilidade em uso prolongado. Atuam retendo água no lúmen intestinal, aumentando o volume e a maciez do bolo fecal.

Polietilenoglicol (PEG / Macrogol)

Considerado o osmótico de **maior eficácia e melhor tolerabilidade**. Não é absorvido, não causa distúrbios eletrolíticos em doses habituais e pode ser usado a longo prazo com segurança. Disponível em sachês (17 g dissolvidos em água). Evidências robustas de eficácia em ensaios clínicos randomizados para constipação crônica e SII-C.

Lactulose

Dissacarídeo sintético não absorvível que é fermentado pelas bactérias colônicas, gerando ácidos orgânicos e gases. Tem efeito osmótico e pode modificar a microbiota. Eficaz, porém com maior incidência de **flatulência, distensão e cólicas** que o PEG. Útil em pacientes com cirrose hepática (encefalopatia). Custo geralmente inferior ao PEG.

Laxantes Irritativos (Estimulantes)

Mecanismo de ação

Os laxantes estimulantes atuam diretamente sobre os neurônios e enterócitos do cólon, **umentando a secreção e o peristaltismo**. Também inibem a absorção de água e eletrólitos, acelerando o trânsito colônico. Têm início de ação rápido (6–12 horas para os orais).

Principais representantes

- **Bisacodil**: comprimidos entéricos ou supositórios. Rápida ação. Útil para alívio agudo.
- **Sene (sennosídeos)**: derivado antraquinônico de origem vegetal. Ação noturna, cômodo para uso antes de dormir.
- **Picossulfato de sódio**: pró-fármaco ativado pelas bactérias colônicas, de ação similar ao bisacodil.

Orientações ao prescrevê-los

Devem ser usados como **resgate ou por períodos curtos**, não como tratamento de manutenção. O uso crônico de antraquinonas pode causar **melanose cólica** (benign pigmentação da mucosa) e, theoricamente, dano aos neurônios entéricos em uso muito prolongado — dado ainda controverso na literatura, mas que justifica a cautela.

- ❑ Evitar uso crônico de laxantes irritativos. Prefira osmóticos (PEG) para tratamento de manutenção a longo prazo.

Agonistas do Receptor 5-HT₄ — Prucaloprida

Mecanismo de ação

A prucaloprida é um agonista seletivo de alta afinidade dos receptores **5-HT₄** (serotoninérgicos) no trato gastrointestinal. Ativa os neurônios colinérgicos ascendentes do plexo mioentérico, estimulando a geração de ondas peristálticas de alta amplitude (HAPC) e acelerando o trânsito colônico de forma fisiológica.

Evidências clínicas

Múltiplos ensaios fase III demonstraram superioridade sobre placebo em constipação crônica, com aumento significativo do número de evacuações completas espontâneas. Aprovada pela ANVISA e pela EMA. Especialmente útil em trânsito lento refratário aos osmóticos.

Posologia e segurança

Dose: **2 mg/dia** (1 mg em idosos ou insuficiência renal). Alta seletividade para receptores 5-HT₄ gastrointestinais minimiza os riscos cardíacos observados com agentes mais antigos (cisaprida). Efeitos colaterais mais frequentes: cefaleia, náuseas e diarreia, geralmente transitórios no início do tratamento.

Secretagogos Intestinais

Os secretagogos atuam aumentando a secreção de fluido para o lúmen intestinal, melhorando a consistência das fezes e acelerando o trânsito. Representam uma classe moderna, com mecanismos de ação distintos dos laxantes tradicionais.

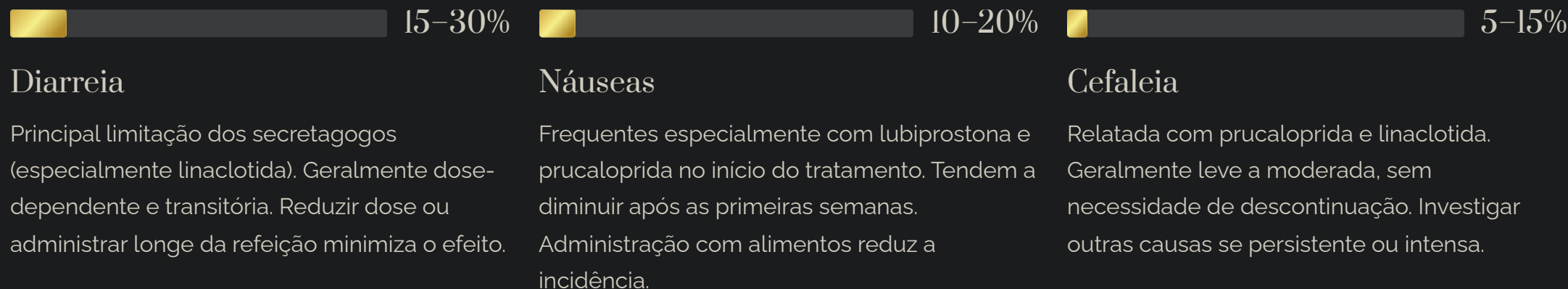
Lubiprostona

Ativador dos canais de cloro tipo 2 (ClC-2) nas células epiteliais intestinais. Aumenta a secreção de fluido rico em cloreto, hidratando as fezes e lubrificando o lúmen. Aprovada para constipação crônica idiopática (adultos) e SII-C (mulheres). **Dose: 24 mcg 2x/dia** para constipação crônica. Principal efeito adverso: náusea (aliviada ingerindo com alimentos).

Linaclotida

Agonista da guanilato ciclase C (GC-C) nos enterócitos. Aumenta AMPc intracelular, estimulando a secreção de cloreto e bicarbonato. Além do efeito secretor, tem **propriedade analgésica visceral** — reduz a hipersensibilidade por ação em fibras aferentes subepiteliais. Particularmente útil na SII-C. **Dose: 145–290 mcg/dia** para constipação; 290 mcg para SII-C.

Perfil de Efeitos Colaterais dos Agentes Modernos



A maioria dos efeitos adversos dos secretagogos e procinéticos é **leve, transitória e dose-dependente**. O conhecimento desse perfil permite que o médico oriente adequadamente o paciente, melhorando a adesão terapêutica e evitando descontinuação precoce desnecessária.

Probióticos na Constipação

Evidências atuais

O uso de probióticos na constipação funcional ainda é área de pesquisa ativa. As evidências são **promissoras, mas ainda heterogêneas**. Metanálises mostram benefício modesto em desfechos como frequência evacuatória e consistência das fezes, especialmente com cepas específicas de *Lactobacillus* e *Bifidobacterium*.

Os mecanismos propostos incluem: produção de ácidos graxos de cadeia curta (estimulantes do peristaltismo), modulação do sistema serotoninérgico entérico e redução do pH colônico (efeito osmótico indireto).

Perspectivas clínicas

- Benefício mais consistente em constipação associada à microbiota alterada
- Cepas com maior evidência: *Bifidobacterium lactis*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus casei*
- Ausência de efeitos adversos relevantes favorece uso adjuvante
- Ainda não recomendados como tratamento de primeira linha pelas diretrizes principais
- Microbioma fecal personalizado é perspectiva futura promissora

Biofeedback — Tratamento de Escolha para Dissinergia

O biofeedback anorretal é o tratamento de **primeira escolha para dissinergia anorretal e anismo**, condições que não respondem a laxantes convencionais porque o mecanismo é funcional e não de trânsito. Consiste no treinamento neuromuscular com retroalimentação visual ou auditiva das pressões anorretais.

01

Como funciona

Um eletrodo ou sonda de pressão é inserido no canal anal. O paciente observa em tempo real no monitor o comportamento de sua musculatura durante simulações de defecação, aprendendo a **relaxar voluntariamente o esfíncter externo** enquanto aumenta a pressão abdominal.

02

Protocolo típico

Geralmente são realizadas **5 a 10 sessões** de 30–45 minutos, com frequência semanal ou quinzenal, conduzidas por fisioterapeuta especializado em assoalho pélvico. Os exercícios domiciliares são parte essencial do protocolo.

03

Eficácia

Taxas de sucesso de **60–80%** em estudos controlados para dissinergia documentada por manometria. Superioridade sobre laxantes osmóticos e diazepam isolados nesse subgrupo específico. Efeitos mantidos a longo prazo na maioria dos pacientes.

Constipação Induzida por Opióides (CIO)

A constipação induzida por opióides (CIO) é uma entidade clínica distinta da constipação funcional primária e exige abordagem específica. É definida como a **alteração no padrão evacuatório basal do paciente após o início do uso de opióides**, com aumento da consistência ou redução da frequência das fezes.

Epidemiologia

A CIO afeta **40 a 90% dos pacientes em uso crônico de opióides**, com as maiores prevalências (próximas a 90%) observadas em pacientes oncológicos em cuidados paliativos. Diferentemente de outros efeitos adversos dos opióides (como náusea e sedação), a tolerância à CIO **não se desenvolve com o tempo**, tornando-a um problema persistente enquanto durar o uso.

Fisiopatologia

Os opióides atuam em receptores μ (mu) e δ (delta) do sistema nervoso entérico, causando:

- Redução da motilidade propulsiva intestinal (menor frequência de ondas peristálticas)
- Aumento do tônus esfinteriano (anal e ileocecal)
- Redução das secreções intestinais
- Aumento da reabsorção de água e eletrólitos
- Comprometimento do reflexo defecatório

Diagnóstico e Critérios da CIO

Critérios diagnósticos

O diagnóstico da CIO requer:

- **Início dos sintomas após o início do uso de opióides** (ou após aumento de dose)
- Presença de 2 ou mais dos seguintes: fezes endurecidas, esforço evacuatório, sensação de evacuação incompleta, sensação de bloqueio anal, necessidade de manobras manuais, menos de 3 evacuações espontâneas por semana
- Relação temporal clara entre uso de opióide e mudança do hábito intestinal

Diagnóstico diferencial

- **Constipação funcional primária:** preexistente ao uso de opióides — importante questionar hábito intestinal basal
- **Obstrução mecânica:** especialmente em pacientes oncológicos com risco de compressão tumoral
- **Hipercalcemia:** frequente em pacientes com metástases ósseas, pode coexistir
- **Disfunção opioidérgica do intestino:** síndrome mais ampla que inclui náusea, saciedade precoce e dispepsia

📌 Regra clínica prática: **todo paciente que inicia opióide deve receber profilaxia laxativa concomitante**, não aguardar o desenvolvimento da constipação. Laxantes estimulantes (bisacodil, sene) são preferidos aos osmóticos como profilaxia.

Tratamento da CIO — Antagonistas Periféricos de Opióides

O grande avanço terapêutico no manejo da CIO foi o desenvolvimento dos **antagonistas periféricos dos receptores μ de opióides (PAMORAs)** — moléculas que bloqueiam seletivamente os receptores gastrointestinais sem cruzar a barreira hematoencefálica, preservando a analgesia central enquanto restauram a motilidade intestinal.

Naloxegol

Dose: 25 mg/dia (12,5 mg em pacientes com risco). Derivado PEGuilado da naloxona com absorção gastrointestinal limitada. Aprovado pela ANVISA para CIO em adultos com dor não oncológica. Altamente eficaz na restauração da frequência evacuatória espontânea. Contraindicado em obstrução intestinal e uso concomitante de inibidores potentes de CYP3A4.

Metilnaltrexona

Dose subcutânea: 8–12 mg em dias alternados ou conforme necessidade. Ação periférica rápida (efeito em 30–60 min na maioria dos pacientes). Indicado para CIO em pacientes com dor oncológica avançada em cuidados paliativos. Disponível na formulação SC e oral. Bem tolerado em pacientes fragilizados.

Estratégia Clínica na CIO



Profilaxia

Laxante
osmótico

PAMORA

Reavaliação

A estratégia clínica deve sempre correlacionar o **início dos sintomas com o uso medicamentoso** e levar em conta o contexto clínico completo do paciente. Em pacientes oncológicos, a constipação tem impacto direto na qualidade de vida e na adesão ao tratamento analgésico. A subutilização de PAMORAs nesse grupo ainda é um problema real que deve ser combatido com educação médica.

Diarreia Funcional — Introdução

A diarreia funcional é um distúrbio gastrointestinal funcional caracterizado por **episódios recorrentes de evacuações com fezes amolecidas ou líquidas**, na ausência de causa orgânica identificável após investigação adequada. Embora menos abordada do que a SII, é uma condição prevalente com impacto significativo na qualidade de vida e produtividade dos pacientes.

Contexto epidemiológico

A prevalência da diarreia funcional varia entre **4% e 17%** na população geral, dependendo dos critérios diagnósticos utilizados. Apresenta distribuição relativamente uniforme entre os sexos, ao contrário da SII, que é mais prevalente em mulheres. O impacto clínico inclui limitação de atividades sociais, ansiedade antecipatória e redução da qualidade de vida.

Ponto de partida clínico

O diagnóstico correto exige excluir causas orgânicas antes de rotular o quadro como funcional. O risco de "diagnosticar" erroneamente uma diarreia inflamatória, malabsortiva ou infecciosa como funcional é real e tem consequências clínicas sérias. A investigação mínima é sempre necessária antes de estabelecer o diagnóstico positivo.

Definição e Critérios de Roma IV para Diarreia Funcional

Segundo os **Critérios de Roma IV**, a diarreia funcional é definida pela presença dos seguintes critérios por pelo menos 3 meses (com início há 6 meses):

Critério principal de consistência

Presença de fezes amolecidas, pastosas ou líquidas (tipos **6 ou 7 da Escala de Bristol**) em pelo menos 25% das evacuações. A consistência é mais relevante do que a frequência como critério diagnóstico.

Ausência de dor predominante

A dor ou desconforto abdominal **não é o sintoma predominante** — elemento essencial que distingue diarreia funcional da SII-D. Se dor for o sintoma central, o diagnóstico correto é SII com diarreia predominante.

Critérios exclusivos

Os sintomas não são explicados por intolerância alimentar, doenças inflamatórias intestinais, infecção, má absorção ou outros distúrbios orgânicos identificáveis. A investigação deve ser proporcional ao risco do paciente.

Diarreia Funcional vs. SII com Diarreia — Distinção Fundamental

Síndrome do Intestino Irritável com Diarreia (SII-D)

- **Dor abdominal recorrente** é o sintoma central e necessário para o diagnóstico
- Dor relacionada à defecação (piora antes de evacuar, alivia após)
- Presença obrigatória de alteração do hábito intestinal associada à dor
- Maior componente de hipersensibilidade visceral
- Impacto psicossocial geralmente mais intenso
- Tratamento inclui neuromoduladores e antidepressivos

Diarreia Funcional (DF)

- Foco principal em fezes **amolecidas/líquidas sem dor predominante**
- Desconforto abdominal pode ocorrer, mas não é o sintoma guia
- Não há relação necessária entre dor e defecação
- Fisiopatologia centrada em motilidade e secreção colônica acelerada
- Tratamento: loperamida, colestiramina e modulação da microbiota
- Prognóstico em geral mais favorável que SII-D

❏ A distinção prática pode ser desafiadora, pois os dois quadros se sobrepõem. Na dúvida, priorize o tratamento do sintoma predominante e reavalie regularmente.

Fisiopatologia da Diarreia Funcional

A fisiopatologia da diarreia funcional é multifatorial e envolve a interação complexa entre motilidade, secreção, microbiota e modulação neural. Os principais mecanismos identificados são:

Alteração da motilidade colônica

Aumento da frequência e velocidade das contrações propulsivas colônicas, com redução do tempo de trânsito. Contrações de alta amplitude mais frequentes e de maior duração impulsionam o conteúdo fecal mais rapidamente, reduzindo o tempo de absorção de água.

Disbiose e microbiota alterada

Alterações quantitativas e qualitativas da microbiota intestinal podem promover produção excessiva de ácidos graxos de cadeia curta, metano ou hidrogênio, alterando a motilidade e a função de barreira epitelial. A diarreia pós-infecciosa pode evoluir para diarreia funcional por mecanismo disbiótico persistente.

Eixo cérebro-intestino

Modulação anormal da via aferente e eferente entre o SNC e o intestino, com participação de serotonina (5-HT₃ e 5-HT₄), CRF (fator liberador de corticotrofina) e o sistema nervoso autônomo. Estresse e ansiedade claramente aumentam a motilidade e a secreção colônica.

Avaliação Clínica da Diarreia Funcional

A anamnese deve caracterizar detalhadamente o padrão diarreico para orientar a investigação e o diagnóstico diferencial. Três domínios são fundamentais:

1

Frequência evacuatória

Número de evacuações por dia e por semana. Diarreia funcional geralmente cursa com **3–6 evacuações/dia**. Frequências muito elevadas (> 8–10/dia) com volume aumentado devem levantar suspeita de causa orgânica ou secretora.

2

Consistência das fezes

Usar a Escala de Bristol: tipos 6 (fezes pastosas com bordas irregulares) e 7 (totalmente líquidas). Fezes com sangue, muco abundante ou gordurosas (esteatorreia) indicam etiologia orgânica e exigem investigação.

3

Volume e características associadas

Volume alto (> 500 mL/dia) sugere causa secretora ou osmótica. Diarreia noturna que acorda o paciente do sono é incomum em diarreia funcional e deve ser investigada. Relação com alimentos específicos orienta investigação de intolerâncias.

Sinais de Alarme na Diarreia

Assim como na constipação, a presença de sinais de alarme na diarreia exige investigação obrigatória para excluir causas orgânicas graves. O diagnóstico de diarreia funcional é de exclusão.



Perda de peso não intencional

Qualquer perda ponderal significativa associada à diarreia deve motivar investigação de neoplasia (principalmente colorretal, linfoma intestinal), DII ou síndrome de má absorção.



Sangue nas fezes

Hematoquezia ou melena associadas à diarreia indicam colonoscopia urgente. Nunca atribuir sangramento a causa funcional sem investigação endoscópica completa.



Anemia

Anemia ferropriva inexplicada em contexto de diarreia pode indicar doença celíaca, DII, neoplasia ou má absorção. Exige investigação laboratorial e eventualmente endoscópica.



Diarreia noturna

A diarreia que desperta o paciente do sono raramente é funcional. Pensar em DII (Crohn, colite ulcerativa), diarreia microscópica, neoplasia secretora e infecção crônica.

Investigação Diagnóstica — Exames Iniciais

Exames de primeira linha

Todo paciente com diarreia funcional suspeita deve ser submetido a uma investigação mínima para excluir causas orgânicas antes do diagnóstico:

- **Hemograma completo:** anemia, leucocitose (infecção), eosinofilia (parasitose)
- **PCR e VHS:** marcadores inflamatórios elevados sugerem DII ou infecção
- **Função tireoidiana (TSH):** hipertireoidismo causa diarreia funcional reversível
- **Glicemia e sorologia celíaca (anti-transglutaminase IgA):** celíaca é frequentemente subdiagnosticada
- **Calprotectina fecal:** marcador de inflamação intestinal — eleva na DII, normal na diarreia funcional

Por que a calprotectina é tão útil?

A **calprotectina fecal** é uma proteína liberada por neutrófilos na mucosa intestinal inflamada. Tem alta sensibilidade e especificidade para distinguir DII de distúrbios funcionais:

- Valor normal (< 50 mcg/g): muito baixa probabilidade de DII ativa
- Valor elevado (> 200 mcg/g): probabilidade alta de DII — indicação de colonoscopia
- Zona cinzenta (50–200): repetir em 6–8 semanas ou considerar colonoscopia

O uso criterioso da calprotectina **reduz o número de colonoscopias desnecessárias** em até 60%.

Investigação Avançada — Quando Indicar

→ Colonoscopia com biópsias

Indicada em pacientes com sinais de alarme, maiores de 50 anos sem colonoscopia recente, calprotectina elevada, ou diarreia noturna. Permite identificar DII, colite microscópica (colágena e linfocítica — causa importante de diarreia crônica aquosa em mulheres de meia-idade), pólipos e neoplasias. As **biópsias aleatórias da mucosa de aspecto normal** são fundamentais para excluir colite microscópica.

→ Elastase fecal

Marcador de **insuficiência pancreática exócrina (IPE)** — causa subdiagnosticada de diarreia crônica e esteatorreia. Valor < 200 mcg/g indica IPE. Indicado em diarreia com esteatorreia, emagrecimento ou história de pancreatite crônica/cirurgia pancreática. Simples, não invasivo e de baixo custo.

→ Teste respiratório com lactulose/glicose

Para investigar **supercrescimento bacteriano do intestino delgado (SIBO)** — associado a diarreia crônica, distensão e flatulência, especialmente em pacientes com dismotilidade, cirurgia intestinal prévia ou uso de IBP de longa data.

Tratamento Farmacológico da Diarreia Funcional

O tratamento deve ser direcionado pelo mecanismo fisiopatológico predominante identificado na avaliação clínica. A abordagem empírica inicial é válida, mas a ausência de resposta exige reavaliação diagnóstica.

Loperamida

Agonista dos receptores μ -opiídeos periféricos. Reduz a motilidade intestinal, aumenta o tônus esfinteriano e diminui a secreção intestinal. É o **antidiarreico de primeira linha** para diarreia funcional:

- Dose: 2–4 mg após cada evacuação líquida (máx 16 mg/dia)
- Não causa dependência nas doses terapêuticas habituais
- Não cruza a barreira hematoencefálica em doses terapêuticas
- Eficaz na redução da frequência e melhora da consistência

Colestiramina

Resina sequestrante de ácidos biliares, particularmente útil na **diarreia por má absorção de ácidos biliares (MAB)** — diagnóstico frequentemente esquecido, especialmente após colecistectomia ou doença ileal. Os ácidos biliares não absorvidos estimulam a secreção e a motilidade colônica:

- Dose: 4 g 1–4x/dia, longe de outros medicamentos
- Pode causar constipação, náusea e dificuldade de deglutição
- Alternativas: colesevelam e ácido ursodioxicolico em doses baixas

Outras Opções Terapêuticas

Probióticos

Evidências crescentes para modulação da microbiota na diarreia funcional, especialmente em diarreia pós-infecciosa e associada ao uso de antibióticos. Cepas com maior evidência: *Saccharomyces boulardii*, *Lactobacillus rhamnosus GG*. Ausência de efeitos adversos justifica uso adjuvante. Impacto ainda modesto em estudos controlados.

Antagonistas 5-HT₃ (Alosetrona)

Reduzem a motilidade gastrointestinal e a hipersensibilidade visceral por bloqueio dos receptores 5-HT₃ nas vias aferentes. Indicados especialmente para **mulheres com SII-D grave**. Uso restrito por risco de colite isquêmica — prescrição controlada em alguns países. No Brasil, disponibilidade limitada.

Rifaximina

Antibiótico de ação luminal (mínima absorção sistêmica) com evidência na **SII-D** e em casos com SIBO. Reduz a carga bacteriana luminal e o metabolismo de ácidos biliares. Ciclos de 2 semanas com boa tolerabilidade e sem resistência significativa a longo prazo. Opção de segunda linha nos casos refratários.

Estratégia Clínica na Diarreia Funcional

O pilar da estratégia terapêutica na diarreia funcional é o **tratamento baseado no mecanismo predominante** identificado na avaliação clínica. Não existe uma abordagem única: cada paciente requer um raciocínio individualizado.



Tratamento 1ª Linha
Loperamida ou colestiramina

Escalonar Terapia
Antagonista 5-HT₃ ou rifaximina



Identificar Mecanismo
Motilidade, secreção ou microbiota



Adicionar Probióticos
Tratar fator desencadeante



- ❑ Sempre que possível, identificar e tratar o fator desencadeante: intolerância ao glúten (celíaca), intolerância à lactose, MAB pós-colecistectomia, SIBO, uso de medicamentos (metformina, IPBs, ISRS) ou infecção latente. O tratamento etiológico supera o sintomático.

Erros Clínicos Mais Comuns

O conhecimento dos erros mais frequentes no manejo das doenças funcionais do TGI é essencial para elevar a qualidade do cuidado e reduzir complicações diagnósticas e terapêuticas.

Não excluir causas orgânicas antes do diagnóstico funcional

O maior erro em gastroenterologia funcional. Rotular precocemente um paciente com "diarreia funcional" sem investigação mínima (calprotectina, sorologias, parasitológico) pode atrasar o diagnóstico de DII, celíaca, câncer colorretal ou parasitose crônica. O diagnóstico funcional é de exclusão.

Tratar constipação apenas com laxantes sem classificar o subtipo

Prescrever laxante osmótico para um paciente com dissinergia anorretal não documentada é ineficaz e pode ser frustrante para o paciente e o médico. A avaliação funcional com manometria ou teste do balão é necessária antes de escalonar o tratamento da constipação refratária.

Ignorar o componente psicossocial

Ansiedade, depressão, trauma e estresse crônico modulam profundamente o eixo cérebro-intestino. Não abordar esses fatores predispõe à refratariedade terapêutica. A integração com psicologia ou psiquiatria deve ser considerada em casos crônicos ou com comorbidades psíquicas identificadas.

Integração Clínica — Um Espectro Funcional

Constipação e diarreia funcionais não são entidades isoladas e opostas — elas representam os **extremos de um espectro contínuo de disfunção intestinal funcional**, compartilhando mecanismos fisiopatológicos, ferramentas diagnósticas e princípios terapêuticos.

Fisiopatologia compartilhada

Ambas envolvem o eixo cérebro-intestino, o sistema nervoso entérico, a microbiota e mecanismos de hipersensibilidade visceral. A mesma alteração neurofuncional pode produzir constipação ou diarreia dependendo do predomínio de inibição ou excitação motora.



Transição entre subtipos

Pacientes com SII podem alternar entre episódios de constipação e diarreia ao longo do tempo, evidenciando que esses subtipos são dinâmicos e não categorias fixas. A alternância é critério para SII com padrão misto (SII-M).



Abordagem clínica integrada

Ambas as condições se beneficiam de intervenções nos pilares comuns: modulação da microbiota, abordagem do eixo cérebro-intestino, identificação de gatilhos alimentares e tratamento das comorbidades psíquicas associadas.

Síntese Final — Constipação e Diarreia Funcional

Dominar o diagnóstico e o manejo da constipação e da diarreia funcionais exige uma abordagem que integra rigor diagnóstico, compreensão fisiopatológica e estratégia terapêutica individualizada. Os três pilares do especialista competente são:



Diagnóstico clínico preciso

Anamnese estruturada, uso dos Critérios de Roma IV, Escala de Bristol, exclusão de sinais de alarme, investigação laboratorial mínima e, quando indicado, testes fisiológicos anorretais. O diagnóstico correto é o passo mais importante de toda a abordagem clínica.



Estratificação correta do subtipo

Diferenciar trânsito normal, trânsito lento e distúrbios da defecação na constipação; identificar o mecanismo predominante na diarreia (motilidade, secreção, microbiota, má absorção de ácidos biliares). A estratificação define o tratamento e evita abordagens ineficazes.



Tratamento direcionado ao mecanismo

Fibras e hidratação → trânsito normal; osmóticos e procinéticos → trânsito lento; biofeedback → dissinergia; PAMORAs → CIO; loperamida e colestiramina → diarreia funcional. Cada subtipo tem sua abordagem ideal: o tratamento inespecífico falha onde o direcionado cura.